

TEMA 10.36 • REUMATOLOGÍA

Raíces Nerviosas en Cervicobraquialgia y Lumbociática

PERFIL EUNACOM 1.10.36

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Importancia

Es fundamental conocer la semiología de las raíces nerviosas para correlacionar la clínica con la resonancia. Si una hernia grande no se correlaciona con la raíz afectada clínicamente, no hay que operarla y se debe completar el estudio.

Raíces Cervicales (Extremidad Superior)

Parte Sensitiva

- **C5:** deltoides y zona anterolateral del brazo. - **C6:** primer dedo (pulgar) + zona lateral del brazo y antebrazo. - **C7:** índice y dedo medio + zona posterior del brazo y antebrazo. - **C8:** cuarto y quinto dedo + zona medial del brazo y antebrazo. - **T1:** zona medial del brazo.

Nemotecnia: C5 en el hombro, C6 en el pulgar, C7 en índice y medio, C8 en lo que queda, T1 en zona medial del brazo.

Parte Motora

- **C5:** deltoides y músculos escapulares. Movimiento: **abducción del brazo y rotación externa del hombro**. - **C6:** bíceps y flexores. Movimiento: **flexión**. - **C7:** tríceps y extensores. Movimiento: **extensión**. - **C8:** **extensión del pulgar** en particular. - **T1:** **abducción y aducción de los dedos** (con algo de C8 también). Las raíces se mezclan un poco y no son tan puras.

Raíces Lumbares (Extremidad Inferior)

Parte Sensitiva

- **L2 y L3:** cara anterior del muslo. - **L4:** comienza lateral en el muslo, va a anterior en la rodilla, luego cara medial de pierna hasta maléolo interno. Resumiendo: **zona medial de pierna y pie**. - **L5:** zona anterior de pierna y pie (empeine) y mayor parte de la planta. - **S1:** zona posterior del muslo, luego zona lateral de pierna y pie. En la pierna: por el lado va S1, al medio L5, la parte medial L4.

Parte Motora

- **L2, L3, L4:** cuádriceps. Movimiento: **extensión de la rodilla**. Reflejo: **patelar (rotuliano)**. L4 y L3 los más importantes. - **L5:**

extensión de los ortejos (especialmente el primer ortejo, similar a C8 que extendía el primer dedo). **No tiene reflejo asociado**. - **S1:** gastrocnemios. Movimiento: **flexión plantar** (pararse en punta de pies). Reflejo: **aquiliano**.

S1: debilidad para pararse en punta de pies + pérdida del reflejo aquiliano. L5: no tiene reflejo (diferencia con L4 = patelar y S1 = aquiliano).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente con lumbociática y debilidad para pararse en punta de pies más pérdida del reflejo aquiliano. ¿Qué raíz nerviosa está afectada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Raíces Nerviosas en Cervicobraquialgia y Lumbociática. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- C5: hombro/deltoides, abducción del brazo; C6: pulgar/bíceps, flexión; C7: índice-medio/tríceps, extensión
- C8: 4to-5to dedo, extensión del pulgar; T1: zona medial del brazo, abducción/aducción de dedos
- L2-L3-L4: cuádriceps, extensión de rodilla, reflejo patelar (L4 el más importante)
- L5: extensión de ortejos (especialmente 1er ortejo), sin reflejo asociado
- S1: gastrocnemios, flexión plantar (punta de pies), reflejo aquiliano
- Sensitivo en pierna: L4 medial, L5 anterior/empeine, S1 posterior/lateral
- Importancia clínica: correlacionar hallazgos semiológicos con imágenes antes de decidir cirugía

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (RAÍCES NERVIOSAS EN CERVICOBRAQUIALGIA Y LUMBOCIÁTICA)

PREGUNTA 1

Paciente con lumbociática y debilidad para pararse en punta de pies más pérdida del reflejo aquiliano. ¿Qué raíz nerviosa está afectada?

- A) L3
- B) L4
- C) L5
- D) S1
- E) S2

PREGUNTA 2

Paciente con cervicobraquialgia y debilidad para extender la muñeca. ¿Qué raíz nerviosa está probablemente afectada?

- A) C5
- B) C6
- C) C7
- D) C8
- E) T1

PREGUNTA 3

¿Qué raíz lumbar no tiene reflejo asociado?

- A) L2
- B) L3
- C) L4
- D) L5
- E) S1

RESUMEN: RAÍCES NERVIOSAS EN CERVICOBRAQUIALGIA Y LUMBOCIÁTICA

Esta clase revisa la semiología de las raíces nerviosas afectadas en cervicobraquialgia y lumbociática, fundamental para correlacionar los hallazgos clínicos con las imágenes (resonancia). Las raíces cervicales C5-C8 y T1 inervan la extremidad superior: C5 inerva el deltoides (abducción/rotación externa del hombro), C6 el bíceps (flexión), C7 el tríceps (extensión), C8 la extensión del pulgar, y T1 la abducción/aducción de los dedos. En la parte sensitiva: C5 el hombro, C6 el pulgar, C7 índice y dedo medio, C8 los últimos dos dedos, T1 la zona medial del brazo. Las raíces lumbares L2-L5 y S1 inervan la extremidad inferior: L2-L3-L4 inervan el cuádriceps (extensión de rodilla, reflejo patelar; L4 el más importante), L5 la extensión de ortejos (primer ortejo especialmente, sin reflejo asociado), y S1 los gastrocnemios (flexión plantar, reflejo aquiliano). En la parte sensitiva: L2-L3 cara anterior del muslo, L4 zona medial de pierna y pie, L5 zona anterior de pierna y empeine, S1 zona posterior del muslo y lateral de pierna y pie.